

10 - 10- LES TOXIDERMIES MÉDICAMENTEUSES - Pr. Hocar

(0:00 - 1:19)

Bonjour tout le monde, j'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui le cours intitulé les toxidermies médicamenteuses. Les toxidermies définissent les effets cutanés des médicaments administrés par voie interne et sont parmi les plus fréquents. Ce qu'on appelle aussi hyatrogénie médicamenteuse, c'est un problème de santé publique avec une fréquence qui est en constante augmentation et s'observe chez 1 à 3 % des utilisateurs de l'emploi médicament d'usage commun.

Il peut y avoir plusieurs types de manifestations, des réactions idiosyncrasiques imprévisibles, mais aussi des réactions pharmacologiques aux toxiques comme les alopecies des antimyotiques. Les objectifs pédagogiques de ce cours sont comme il suit, d'abord reconnaître les formes cliniques des toxidermies médicamenteuses, reconnaître les signes de gravité d'une toxidermie et reconnaître les critères d'imputabilité important pour retenir le diagnostic d'une toxidermie. Plus de 90 % des toxidermies sont bénignes, les formes qui mettent en jeu le pronostic vital sont très rares, trop rares pour être détectées lors des essais précédents de l'autorisation de mise sur le marché d'un médicament donné.

(1:20 - 1:54)

Ces toxidermies graves ou non connues doivent, je le dis bien, doivent être notifiées aux instances de pharmacovigilance. Dans leur très grande majorité, les toxidermies se manifestent par des signes cutanés plus spécifiques et les formes les plus fréquentes sont les éruptions érythémateuses ou ixanthèmes maculopapuleux dans 40 à 60 % des notifications, suivies par les urticaires dans 20 à 30 % des notifications. Sur le plan clinique, les toxidermies ont des aspects cliniques variés, non spécifiques.

(1:54 - 7:48)

Pour l'érythème pycnothéfix, c'est une forme clinique très spécifique de toxidermie, il est exclusivement médicamenteuse. On a d'autres formes comme la necrolisipédermie toxique, la pustulose ixanthématique et du généralisé qui sont quasi spécifiques d'une origine médicamenteuse. Les toxidermies les plus fréquentes sont les éruptions érythémateuses ou ixanthèmes maculopapuleux dans 40 à 60 % des cas qui sont souvent bénignes, sauf la forme de syndrome d'hypersensibilité médicamenteuse, suivie par les urticaires aussi bénignes dans la majorité des cas, sauf bien sûr dans le cadre du choc anaphylactique.

Nous allons voir en premier les ixanthèmes dont leur forme habituelle, l'éruption débute entre 4 et 14 jours après le début du traitement. On peut appeler aussi l'érythème du 9ème jour, l'atteinte initiale prédominante sur le tronc ou la racine des membres avec une extension possible pendant quelques jours. En faveur du diagnostic, c'est le polymorphisme des lésions associant chez un

même malade des macules isolées, dans la plupart des temps c'est des macules morbidipans, c'est-à-dire c'est des lésions érythémateuses avec l'espace de procès, associées des fois à des nappes scarlatiniformes ou des papules ou plaques odémateuses avec parfois une disposition arciforme.

On peut voir sur les extrémités, surtout sur les jambes, un purpura pététhial. Le prurite est souvent fréquent, parfois sévère et la fièvre est peut-être modérée ou absente. On peut aussi noter l'absence des lésions érythémateuses, parfois squammeuses ou fissurées, peuvent toucher le versant semi-muqueux des lèvres, comme une chéilite fissurée ou au niveau du scrotum.

Généralement, la durée d'éruption est habituellement moins d'une semaine et l'évolution parfois se fait vers une fine desquamation. S'il y a une éruption scarlatiniforme, on a une desquamation scarlatiniforme. La biopsie cutanée et toxidermie érythémateuse ou maculopapuleuse montre de la nécrose kératinocytaire, mais l'image n'est pas spécifique.

Les exantèmes sont de cause médicamenteuse dans 50 à 70 % des cas chez l'adulte, alors que chez l'enfant, la fréquence diminue vers 10 à 20 % pour laisser la place aux causes virales, notamment les éruptions des maladies infectieuses, qu'elles sont réactionnelles à un germe avec élimination de toxines. Les principaux arguments en faveur d'une éruption d'origine infectieuse sont le comptage, le syndrome infectieux, les nœuds et le monomorphisme de l'exantème. Chez l'enfant, la plupart des éruptions ont une cause infectieuse.

Les toxidermies sont majoritaires chez l'adulte. Les médicaments en cause sont souvent les aminopénicillines, les bêta-lactamines, les sulfamides, les antibactériens, les céphalosporines et les anticonvulsifs. Voici l'exemple d'un exantème maculopapuleux avec une éruption morbidiforme sur le tronc chez un jeune suite à la prise de bêta-lactamines.

Le diagnostic d'un exantème maculopapuleux impose la recherche de signes de gravité. Ces signes de gravité sont résumés comme il suit, la diffusion des érythèmes, l'infiltration des lésions particulières, si on a un œdème du visage ou un œdème du cou, si on a de la fièvre qui est très élevée, la présence d'adénopathie à l'examen clinique, notamment des adénopathies cervicales, axillaires et inguinales, des douleurs cutanées ou muqueuses intenses, une éruption muqueuse avec des érosions muqueuses sur le versant buccal des lèvres, mais aussi érosion palatine, l'apparition d'un signe de nécrose et l'apparition d'un furuncle ou de la nécrose. Il faut noter que l'apparition de l'un ou l'autre de ces marqueurs de gravité imposent l'arrêt du médicament suspect et l'hospitalisation éventuellement dans une unité de soins adaptée à ce genre de patients.

Un exantème maculopapuleux peut évoluer vers une forme grave de toxidermie qu'on appelle le syndrome d'hypersensibilité médicamenteuse ou DRESS syndrome. DRESS pour dire Drug Reaction with Eosinophilia and Systemic Symptoms. C'est un symptôme, c'est enfin une forme clinique de toxidermie qui est caractérisée par la gravité et l'étendue de l'éruption.

Parfois carrément on peut avoir une érythrodermie. Elle est caractérisée aussi par l'infiltration de l'éruption avec en particulier un oedème du visage, le prurite qui est souvent féroce et sévère, la présence des adénopathies diffuses, la fièvre qui est souvent élevée, peut atteindre les 40, des atteintes viscérales parfois graves, notamment une hépatite biologique, une pneumopathie interstitielle qui peut se manifester cliniquement par de la toux sèche, une dyspnée mais aussi radiologiquement, une néphropathie interstitielle qui se manifestera par l'oedème mais aussi par la protéinurie avec les bandelettes urinaires qui sont positives et la présence d'une protéinurie positive à la hauteur des urines de 24 heures, on peut avoir aussi des signes cardiaques qui vont se manifester, se forment du myocarde. Sur le plan de l'hémogramme, on peut avoir une éleueuse hémophilie, souvent supérieure à 1 500 éléments par millimètre cube, mais elle peut parfois être retardée et souvent on peut avoir un syndrome mononucléosique avec une lymphocytose aussi, c'est un signe important du Dress syndrome.

(7:48 - 8:31)

Les réactions du virus du groupe herpès sont incriminées dans l'apparition de ce syndrome, de cette forme clinique, notamment l'herpès virus 6 et 7, l'Epstein-Barr virus et le cytomégalovirus. Vous notez que ce tableau, quoique rare, il survient plus tardivement que les toxidermies banales et bien sûr ça impose une prise en charge adaptée à ce genre de toxidermie. Et il faut noter aussi le délai important de deux à six semaines après la prise du médicament, c'est le délai le plus allongé des formes de toxidermie qu'on va voir.

(8:33 - 9:29)

Là, c'est le tableau clinique d'une personne qui a eu un Dress syndrome suite à la prise de l'alloperinol. C'est une personne qui a eu un début d'insuffisance rénale chronique et son nephrologue lui a prescrit de l'alloperinol dans le sens préventif d'une hyperuricémie. Et là, elle présente un tableau fait, comme vous voyez, d'une rétrodermie associée à une cytolysse et à des signes en faveur du Dress syndrome.

Les diagnostics différentiels de ce tableau, surtout, c'est les autres causes de rétrodermie, notamment le psoriasis, les derniers deux contacts, l'élan pompé et l'hermotrope, comme le mycosis mangoui, des syndromes de césarie. Et aussi, bien sûr, il faut se baser sur une bonne anamnèse et l'histologie cutanée et l'analyse de formules sanguines. On peut aussi penser à des syndromes d'hyperiosynophilie primitives ou secondaires si on a une hyperiosynophilie majeure.

(9:30 - 12:07)

Ce syndrome d'hypersensibilité médicamenteuse, il est de cause médicamenteuse dans 70 à 90 % des cas et les médicaments en cause sont souvent des anticommissons, des sulfamides, des inhibiteurs, des enzymes de conversion, minocyclines, surtout chez la population à phototypes

foncés. Donc, les sujets à points noirs semblent avoir un risque accru, surtout de Dress syndrome avec les minocyclines. Donc, faire attention quand on prescrit les minocyclines chez une personne de phototypes 4. Et bien sûr, il y a l'allopérinole aussi, c'est un médicament qui incrimine souvent dans notre contexte, donc des toxidermies graves.

Nous allons voir maintenant une urticaire. On l'a vu d'ailleurs dans le cours de l'urticaire. Elle peut être d'origine médicamenteuse.

C'est une toxidermie qui reste bénigne. Le patient généralement va faire une urticaire immédiate avec l'apparition de papules mobiles et fugaces quelques minutes à quelques heures après l'administration des médicaments. Cela signe le plus souvent une sensibilisation préalable et contre-indique formellement l'emploi ultérieur sans précaution du même médicament, vu le risque important d'anaphylaxie.

L'urticaire du septième jour de traitement est souvent fixe. À ce moment, on bascule dans les urticaires d'origine vasculitique. En cas d'arthralgie associée, évoquez une maladie sérique, c'est-à-dire en réaction à l'injection de protéines étrangères, à sérum ou à parfum, ou une pseudo maladie sérique, faisant le plus souvent suite à l'administration d'antibiotiques.

Le diagnostic d'urticaire ne prête pas à confusion et il faut se garder d'attribuer trop facilement ce tableau à un médicament. Moins de 10% des urticaires aigus ont une cause médicamenteuse. Les médicaments sont souvent incriminés, souvent l'émpancilline et les produits de contraste IOD.

Là, c'est une personne qui a eu de l'urticaire immédiate après injection de produits de contraste IOD pour un examen radiologique et là on voit l'apparition des plaques urticariennes sur sa peau, donc c'est des plaques typiques oedémateuses, r-oedémateuses, ces formes de papules d'urtiques. Bien sûr, il faut se garder à l'esprit le risque de formes graves comme l'angio-oedème ou l'oedème de puncto-choc anaphylactique qui sont souvent de cause médicamenteuse dans 30% des cas avec une menace de risque vital dans 5% de l'intérêt des mesures d'urgence pour sauver ce genre de patient. Les médicaments en cause sont souvent les curares, les curarizants, les ANS, les inhibiteurs d'enzymes de conversion, sérums et vaccins.

(12:09 - 22:13)

Voilà l'aspect qu'on peut avoir lors d'une urticaire profonde d'origine médicamenteuse avec un risque d'atteinte ORL, donc il faut faire attention. Nous arrivons maintenant à une forme clinique de toxidermie qui est de cause exclusivement médicamenteuse. L'héritage pigmentif est une toxidermie, pas thorinolimunique, d'origine médicamenteuse.

C'est la seule dermatose de cause exclusivement médicamenteuse et elle est rare, mais dès qu'on l'a, il faut penser qu'il y a un médicament derrière. Elle débute dans les heures, je dirais moins de 48 heures suivant la prise du médicament inducteur, selon le paracétamol et les ANS, mais aussi du supramide. On peut avoir quelques plaques érythémateuses, quand je dis

quelques, c'est une à dix plaques érythémateuses, arrondies de quelques centimètres de diamètre, souvent douloureuses et infiltrées, et peuvent se couvrir d'une bulle.

À ce moment, on va parler de l'érythème pigmenté fixe bulleux, une forme que vous allez revoir dans le cours des dermatoses bulleuses. L'évolution se fait vers des lésions inflammatoires qui vont disparaître, et puis quelques jours après, elle laisse des taches pigmentées résiduelles, brunes ou ardoisées, et en cas de réintroduction du médicament inducteur, les lésions vont récidiver au même site. Donc érythème, parce qu'au départ ça commence par la rougeur, pigmenté parce que ça disparaît, laisse sa place à une tache pigmentée et fixe parce que ça se reproduit au même endroit, au même site, suite à la reprise du médicament.

Les localisations préférentielles sont souvent les organes génitaux où les lèvres sont assez fréquemment touchées, mais la teinte des muqueuses est rarement multifocale. On peut avoir une lésion, deux ou trois, ou ça peut aller jusqu'à des plaques et peuvent être bulleuses ou non bulleuses. Cette photo montre un patient qui présente un érythème pigmenté fixe dans la forme débutante, donc on voit des plaques érythémateuses avant que ça cicatrise et laissant la plaque pigmentée fixe résiduelle.

Là, c'est une plaque résiduelle pigmentée après l'évolution d'une toxidermie d'érythème pigmenté fixe suite à la prise d'ANS, donc le patient va garder cette plaque pigmentée résiduelle qui va bien sûr devenir érythémateuse quand on réintroduit le médicament en cause. Ici, une patiente qui présente un érythème pigmenté fixe bulleux suite à la prise de sulfalé. Là, c'est une autre vue de la même patiente, on voit les plaques qui sont pigmentées et qui sont bulleuses, on a des décollements, des érosions au niveau du centre des lésions.

Nous arrivons maintenant à une forme clinique sévère, c'est la pustulose exotympanique aiguë généralisée et se caractérise par une éruption brutale et préfébrile selon prise à tort pour une infection grave. Elle débute en général un à quatre jours après l'administration du médicament inducteur, selon un antibiotique, par de la fièvre et un érythème en apes, scarlatinifant, prédominant dans les grands plis, souvent au niveau des aisselles ou plis de laine. En quelques heures, l'érythème se recouvre de nombreuses pustules microbiennes, anicrobiennes je veux dire, superficielles, de petite taille, donc leur taille est inférieure à deux millimètres, à contenu lactescent.

Par endroits, la confluence des pustules peut entraîner un décollement partiel de la partie superficielle soccarnée de l'épiderme. On peut avoir une altération de l'état général, une hyperleucocytose à polynucléaire neutrophile parfois considérable sur l'hémogramme et la biopsie cutanée, si on fait, on trouve une accumulation de polynucléaire neutrophile dans la partie superficielle de l'épiderme réalisant des pustules soccarnées. L'évolution se fait vers la régression rapide après l'arrêt du médicament.

Les pustules disparaissent en quelques jours avec une desquamation diffuse et il faut noter c'est

une forme clinique qui mime à tout point, soit sur le plan clinique, soit sur le plan histologique, un pso-pustuleux, d'ailleurs c'est le grand diagnostic différentiel, c'est une variante éruptive rare du pso-pustuleux qui se distingue de la pustuleuse aiguë exanthématique généralisée par un début qui est moins brutal, la forme médicamenteuse est plus brutale, l'évolution est plus prolongée de la forme du psoriasis alors que c'est de toxidermie, il va rapidement cicatriser dès qu'on a arrêté le médicament en cause. Des aspects un peu différents à la biopsie cutanée mais ça reste globalement les mêmes signes histologiques et bien sûr si on a des antécédents de psoriasis ça va nous aider à retenir le diagnostic d'une forme pustuleuse du pso. Donc il faut noter que le risque vital est menacé entre 1 et 2 % des cas.

Voici des pustules amicrobiennes sur une nappe d'érythème continu carlatiniforme dans le cadre d'une pustuleuse aiguë généralisée exanthématique secondaire à la prise de fluoroquinolone. Il faut noter que le diagnostic différentiel principal c'est le pso pustuleux donc il faut bien sûr refaire l'interrogatoire pour éliminer un contexte de psoriasis. Une autre patiente qui présente elle aussi une pustuleuse aiguë exanthématique généralisée secondaire à la prise d'antibiotiques type bêta-lactamine.

On voit très bien la nappe d'érythème étendue associée à des lésions pustuleuses. La cause médicamenteuse est retrouvée dans 70 à 80 % des cas en cas de pustuleuse exanthématique aiguë généralisée. Les médicaments en cause sont souvent les aminopénicillines, les macrolides et les inhibiteurs calciques.

Nous arrivons maintenant à un type de toxidermie qui est le type le plus grave, c'est le syndrome de Steven Johnson et de Lyell. Ce sont les formes les plus graves de toxidermie. Il existe un continuum entre le syndrome de Steven Johnson et le syndrome de Lyell qui ne sont actuellement distingués que par la surface bupilaire nécrosée qui reste le facteur majeur de gravité.

Les mêmes médicaments sont responsables de tous les grades de sévérité et chez de nombreux patients l'éruption s'étend en quelques jours passant de syndrome de Steven Johnson à un Lyell. Le début généralement se fait vers le 7^e ou 21^e jour après le début de traitement qui est un tableau peu spécifique par des manifestations cutanéo-muqueuses faites de fièvre, brûlure oculaire, pharyngie, éruption érythémateuse et puis rapidement l'évolution se fait vers la phase d'état. En quelques heures à quelques jours le tableau devient caractéristique avec des érosions muqueuses multifocales, des bulles cutanées, un signe de nécrosis positif et au cours de syndrome de Steven Johnson on peut avoir des bulles et des vésicules disséminées qui restent intactes et distinctes de petite taille.

Les ondes de décollement par confluence sont limitées. Dans le syndrome de Lyell, de vastes lambeaux d'épidermes sont décollés mettant à nu le derme sous-jacent aux bulles ou décollables restant en place avec un aspect de linge froissé. La fièvre est constante, l'état général se voit gravement altéré, on peut avoir des atteintes viscérales avec une polyurie et hypoxémie qui peut

témoigner d'une écrose de l'épithélium bronchique et de pronostics très défavorables.

Les examens biologiques se font avec un démogramme qui va montrer une leucopénie, évasion de multiples enzymes, parfois des troubles hydroélectrolytiques résultant de déperditions cutanées. La biopsie cutanée n'est pas indispensable, elle peut montrer l'épiderme nécrosée et aussi on peut avoir le derme qui peut modifier avec légèrement un infiltrat lymphocytaire. Le pronostic vital et fonctionnel est menacé avec un risque de mortalité élevée qui peut atteindre 20 à 25% et la cicatrisation rapide qui se fait dans 10 à 30 jours avec des séquelles assez fréquentes, surtout pigmentées au niveau cutané, mais cicatricielles au niveau muqueux, surtout avec une atteinte oculaire qui pourrait être sévère.

Là c'est un patient qui a une chéilite érosive secondaire à une prise médicamenteuse dans le cadre d'un syndrome de Stevens-Johnson. Un patient qui a présenté un laïl secondaire à la prise de sulfamide, on voit des plaques érosives secondaires à un décollement de l'épiderme. Voilà l'aspect de la peau décollable ou l'aspect de linge mouillée, donc c'est un patient qui présente un laïl.

Là c'est une jeune fille qui présentait un syndrome de Stevens-Johnson, donc on voit que ce sont des macules légèrement perpéruïques, visiculeuses, qui sont distinctes et peu coalescentes dans le cadre d'un Stevens-Johnson secondaire à des anticonvulsions. Un jeune homme qui a présenté un laïl Stevens-Johnson ou ce qu'on appelle un syndrome de chevauchement et c'est un patient qui a eu cette forme clinique grave suite à la prise de Tegretol qui est un antidépilique. Il faut noter que la surface atteinte en cas de syndrome de Stevens-Johnson est généralement inférieure à 10%, en cas de laïl elle est supérieure à 30%.

(22:13 - 23:32)

Entre les deux, on parle de syndrome de chevauchement Stevens-Johnson-laïl. Comme je vous ai dit, il y a les atteintes viscérales, il y a la fièvre, les altérations de l'état général et la mortalité qui peut aller jusqu'à 30% en cas de syndrome de laïl, de l'intérêt de faire un diagnostic précoce et bien sûr adresser le patient à une unité de soins adaptée à ce genre de prise en charge, surtout soins intensifs en matière de laïl Stevens-Johnson. On peut avoir d'autres formes cliniques, notamment le curcural d'origine médicamenteuse.

Les causes sont retrouvées dans 8% des cas, donc le délai généralement entre le 7e et le 21e jour de prise du médicament, on peut avoir un curcural. Le risque vital n'est pas menacé, donc inférieur à 5% et les médicaments en cause sont souvent les produits de contraste iodé, les sulfamides, les sérums, les vaccins, les fibrinolytiques. On peut avoir plusieurs formes de curcural, on peut avoir un curcural pititiel, un curcural ambibis, un curcural équimotique et bien sûr il faut un délai compatible et il faut bien sûr éliminer les autres causes de curcural qui sont les plus fréquentes que la cause médicamenteuse, notamment d'origine thrombopénique et d'origine vasculite.

(23:33 - 24:26)

Un autre tableau de toxidermie, c'est la photosensibilité. Il est facilement reconnu sur une anamnèse correcte qui va montrer que les lésions surviennent dans les heures qui suivent une exposition solaire et la localisation des lésions au niveau des zones découvertes. On peut avoir deux variantes de photosensibilité, ce qu'on appelle une photoallergie, donc le patient va présenter des lésions d'eczéma qui vont débiter aux zones exposées mais peuvent s'étendre aux zones couvertes, parfois déclenchées par des expositions solaires minimales.

Exceptionnellement ils vont persister malgré l'arrêt du médicament inducteur, ce qu'on appelle la photosensibilité persistante. Et le deuxième type, c'est la phototoxicité, dépendant à la fois des doses du médicament et des doses du VA. Ses principaux tableaux cliniques sont les supercours de soleil.

(24:26 - 30:00)

Malgré une exposition limitée, on peut avoir des brûlures tendues des mains ou des jambes, ce qu'on appelle une pseudoporfurie, parce que la porfirie c'est une photodermatose, il faut lui parler d'hermato, et quand le patient présente ça on peut appeler ça pseudoporfurie. Et on peut avoir aussi des décollements, un décollement distal douloureux de la tablette, des ongles, ce qu'on appelle une onycholyse d'origine solaire, photo onycholyse. Des autres causes possibles de photosensibilité sont nombreuses.

On peut avoir une photosensibilité endogène, métabolique, comme les porphyries, les lupus érythémateux ou idiopathiques, ce qu'on appelle les allergies solaires, ou photosensibilité de contact. À ce moment-là, comme contact avec des plantes ou du parfum, des topiques, donc le soleil va jouer le rôle d'un catalyseur pour faire apparaître cette réaction allergique. L'absence d'antécédents de réaction de photosensibilité est un argument de quoi pour une cause exogène, médicamenteuse de contact.

Voilà un tableau de photosensibilité avec des lésions bulleuses, et on voit très bien la marque de la montre qui traduit que la zone protégée du soleil n'avait pas de lésions, alors qu'ailleurs on a des lésions bulleuses, tendues, comme vous les voyez. On peut avoir d'autres tableaux cliniques, ce sont des dermatoses qu'on connaît en dermatologie, mais qui sont souvent soit induites, soit aggravées par des médicaments, par exemple le psoriasis, qui pourrait être aggravé par une prise de corticoïdes, parfois orale, mais aussi par la prise des antépalléièmes synthétiques, de la ténginafine. Le lupus, donc il y a certains médicaments qui peuvent induire un lupus, et pour aggraver cette photosensibilité, donc il faut les éviter.

Le panfégus, il y a certains médicaments qui peuvent induire des lésions de panfégus. L'acné, on a les corticoïdes aussi qui peuvent induire l'acné. On a certains types d'antiviraux et certains types de vitamines B, qui peuvent induire de l'acné.

Le lichen ou des dermatoses liquidoïdes, donc on peut avoir des médicaments qui causeraient du lichen, donc il faut bien sûr faire un inventaire chez les patients qui présentent ces dermatoses-là pour éliminer ou incriminer un médicament qui pourrait induire ou aggraver ces dermatoses-là. Le délai généralement est atypique, ça peut aller quelques semaines à quelques mois de prise, surtout pour les dermatoses liquidoïdes. La recherche de la cause d'une toxidermie repose sur un faisceau d'arguments, mais aucun n'a une valeur absolue.

Ce qu'on appelle la démarche d'imputabilité suivie en pharmacodulance, c'est le degré d'imputabilité de chaque médicament pris par le patient qui est mesuré par un score qui intègre des données chronologiques et des données simiologiques. Il existe de nombreux pièges dans l'interrogatoire médicamenteux, omission de ce qui n'est pas considéré comme médicament, comme les analgésiques ou les somnifères préoccasionnellement, les idules courants de synthèse, les produits de médecine parallèles et l'attribution par excès d'un événement à la prise du médicament en coïncidence. On va commencer d'abord par l'imputabilité chronologique.

On a ce qu'on appelle les délais évocateurs, ce qu'on a vu tout à l'heure, chaque forme, il y a un délai particulier, donc il diffère selon le type de réaction. Il y a l'évolution, les algorithmes d'imputabilité considèrent qu'une amélioration après l'arrêt du médicament ou une aggravation après sa poursuite sont des arguments en faveur de la relation de causalité. Et puis la réintroduction, ça veut dire que la reproduction de la toxidermie après réintroduction volontaire du médicament suspect est évitée et une récurrence après la réintroduction accidentelle ou moins rarement un antécédent d'un effet analogue lors d'une prise antérieure en la même valeur, rendant l'imputabilité très vraisemblable.

Il y a aussi ce qu'on appelle l'imputabilité sémiologique. C'est quoi cette imputabilité sémiologique ? La clinique. On pose la question, la clinique est-elle caractéristique d'un accident médicamenteux ? Pourquoi ? Parce que ces formes de toxidermie, si on les a étudiées, c'est pour les caractériser.

Cela peut être considéré comme acceptable pour le syndrome de Steven Johnson, pour le syndrome de Leyel et la PEAG, c'est-à-dire la pustuleuse aiguë xanthématique généralisée. Il y a des facteurs favorisant dans les toxidermies qu'il faut les noter comme d'ailleurs ce que j'ai mis ici, lupus, infection virale, HIV. Leur présence augmente la probabilité que l'éruption est une cause médicamenteuse.

Il faut noter que l'atopie qu'on a vu au cours du cours d'examen n'est pas un facteur de risque de toxidermie. Certains infections virales sont les facteurs favorisant les mieux documenter. Au cours d'une mononucléose infectieuse, un traitement par aminopénicilline entraîne presque toujours une éruption hérétemoiteuse.

Après guérison de la mononucléose, le risque d'éruption aux aminopénicillines redevient le même que dans la population générale. L'infection par le VIH augmente le risque de toxidermie

aussi bien pénible que grave. Les raisons de ce risque à peu ne sont pas connues.

(30:01 - 32:25)

Le syndrome d'hypersensibilité médicamenteuse est associé à une réactivation du virus du groupe herpès type HHV-6, 7, et puis c'est un var-virus et c'est oméga-le-virus. Bien sûr, il faut éliminer les autres causes, essentiellement la démarche d'imputabilité peut justifier des investigations exhaustives quand on suspecte un médicament absolument indispensable aux patients. À côté de l'imputabilité chronologique et l'imputabilité simbiologique, il y a l'imputabilité extrinsèque, ce qu'on peut dire la notoriété, donc ça se fait par la connaissance des médicaments qui sont des inducteurs les plus fréquents d'un type donné de toxidermie.

Et ça c'est en pratique un argument fort de la démarche d'imputabilité chez un patient prenant plusieurs médicaments. Il ne s'agit bien entendu que d'un argument de probabilité. La liste des médicaments le plus souvent en cause pour chaque variété de toxidermie est indiquée dans des tableaux faits à cet effet dans les centres de pharmacovigilance.

Donc, au terme de cette démarche qui est du ressort du médecin de pharmacovigilance, on détermine les médicaments suspects en cas de réaction grave, l'utilisation ultérieure de ce médicament est contre-indiquée par écrit sur un document remis aux malades sur le carnet de santé. Donc, ce que vous voyez ici, c'est une diapo qui résume tout ce qu'on a vu, toutes les formes de toxidermie et avec leur délai, avec leur aspect clinique et les médicaments en cause. Et bien sûr, ce qu'il faut faire côté imputabilité intrinsèque, extrinsèque, simiologique, chronologique, le bilan paraclinique de chaque porte et son niveau de vie.

C'était pour vous dire que le diagnostic de toxidermie est un diagnostic de présomption fondé sur un faisceau d'arguments simiologiques, chronologiques et extrinsèques. Il faut bien sûr faire attention aux formes graves, notamment la pustule aux aigus, xanthématiques généralisées, le syndrome de l'AL, Steven Johnson et le DRESS syndrome. Et dès qu'on suspecte une toxidermie grave, il faut arrêter le médicament suspect et qui doit être contre-indiqué à vie par écrit aux patients.

Et ne pas omettre de notifier toute toxidermie au centre de pharmacovigilance régionaux et nationaux. Je vous remercie pour votre attention.